

TRAUMATISMOS FACIALES: GENERALIDADES

Elena Salomé Bullejos Martínez, Raúl Antúnez-Conde, Gema Arenas de Frutos, Samuel Espías Alonso, Pablo Montes Fernández-Micheltorena, Eduardo Monteserín Martínez, Marta Peña Barreno.

INTRODUCCIÓN

Los traumatismos faciales se producen con frecuencia en el contexto del paciente politraumatizado. Las lesiones de la cara pueden implicar fracturas faciales y/o lesiones de estructuras nerviosas y viscerales.

El tratamiento definitivo de los traumatismos maxilofaciales puede diferirse hasta que se haya asegurado la vía aérea, se halla tenido control de shock y/o hemorragia y tratado las lesiones neuroquirúrgicas, torácicas, abdominales y neurovasculares de las extremidades.

RECONOCIMIENTO PRIMARIO DEL PACIENTE POLITRAUMATIZADO

Evaluación primaria con el fin de identificar la mayor amenaza para la vida y realizar precozmente las maniobras necesarias para reanimar al paciente. En el reconocimiento primario haremos uso de la regla **ABCDE**:

- **A:** Vía aérea con control de la columna cervical.
- **B:** Respiración y Ventilación.
- **C:** Circulación y control hemorrágico.
- **D:** Discapacidad, valorar estado neurológico.
- **E:** Exposición + Entorno.

RECONOCIMIENTO SECUNDARIO DEL PACIENTE POLITRAUMATIZADO

Detectar lesiones de índole grave y asentar prioridades en el tratamiento. **AMPLIA**: regla nemotécnica para realizar la historia clínica:

- **A** Alergias medicamentosas.
- **M** Medicación previa (anticoagulantes, antiagregantes).
- **P** Enfermedades previas, posible embarazo, EPOC, DM II, HTA, ICTUS, asma, neoplasias, etc.
- **L, I** Lugar/Incidentes relacionados con el traumatismo. Preguntar sobre el mecanismo de lesión.
- **A** Alimentos ingeridos previamente. Último alimento

Paciente estable se reevalúa completamente al paciente y sus lesiones.

- Paciente monitorizado: constantes viales, SatO₂, glucemia, monitor cardíaco/telemetría.
- Exploración facial sistemática.
- Pares craneales, función sensitiva (dolor, hipoestesias, disestesias, etc.).
- Exploración ocular (movimiento, tamaño, simetría pupilar).
- Realizar pruebas diagnósticas específicas: Analítica sanguínea y radiológicas: radiografías y/o TAC cráneo-facial.

RECONOCIMIENTO TERCIARIO DEL PACIENTE POLITRAUMATIZADO

Tras resolver las lesiones potenciales en el reconocimiento primario y secundario se debe de

tratar de identificar nuevamente cualquier lesión potencial no identificada anteriormente, aquellas que ponen en peligro la vida del paciente.

Se debe de realizar nueva evaluación física y de pruebas de imagen y de laboratorio (Hemograma, bioquímica y coagulación). Las pruebas radiológicas clásicas para identificar las estructuras faciales incluyen:

- Radiografía. Radiografía posteroanterior y lateral de cráneo, Waters, Cadwell, Hirtz. Según clínica.
- Ortopantomografía.
- La TAC facial. Es la prueba Gold Estándar para el correcto diagnóstico y planificación quirúrgica de las fracturas faciales.

EXPLORACIÓN MAXILOFACIAL

La exploración facial se debe realizar de forma simétrica y mediante palpación bimanual, siguiendo un orden establecido.

- **Exponer** el área afectada y **limpiar las heridas**.
- Valorar **asimetrías**.
- **Cuero cabelludo**: buscar hematomas, hundimientos, crepitación.
- **Ojos y órbita**: exploración prioritaria antes de que el edema dificulte la apertura palpebral. Valorar:
 - Agudeza visual, diplopía, movimientos oculares.
 - Simetría pupilar y reflejo fotomotor
 - Proptosis, enoftalmos
 - Tumefacción/equímosis periorbitaria, edema/ hemorragia subconjuntival.
 - Lesiones en conjuntiva, párpados, vías lagrimales
 - Exploración oftalmológica profunda.
 - De extrema urgencia: hematoma retrobulbar (dolor ocular, proptosis, pérdida agudeza visual) requiere drenaje urgente.
- **Región nasal**: buscar deformidad, dolor, dificultad respiratoria El hematoma septal debe ser evacuado de forma urgente para evitar necrosis del cartílago septal. Valorar epistaxis y rinolicuorrea / rinorraquia que nos puede indicar una fractura de la base del cráneo.
- Valorar **distancia intercant**: si está aumentada: fractura NOE.
- Exploración de la **sensibilidad** (nervio trigémino) y la **función motora** (nervio facial).
- **Ingurgitación venosa facial**: indica lesiones de los grandes vasos del cuello. **Enfisema** alrededor de cara y ojo: fracturas faciales con afectación sinusal.
- **Arbotantes maxilofaciales**: palpar y descartar escalones óseos.
- **Cavidad oral**: buscar heridas, fracturas/ luxaciones/ avulsiones dentales, hematomas. Hematoma sublingual puede indicar fractura mandibular.
- Descartar alteraciones de la **movilidad mandibular** y de la oclusión.
- Realizar **maniobra de Le Fort**: sujetar los dientes anteriores del maxilar superior con una mano seguido de una manipulación simple. Confirmar si existe movilidad del maxilar lo que indicará que hay fractura.

VÍA AÉREA EN EL PACIENTE POLITRAUMATIZADO CON TRAUMATISMO FACIAL

En muchas ocasiones el traumatismo facial asocia compromiso de la vía aérea. Situaciones que

complican el manejo de la vía aérea:

- **Fracturas** del tercio medio facial tipo **Le Fort II y III. Fractura mandibular bilateral o conminuta.**
- **Pérdida de control voluntario de la lengua** ante la disminución del nivel de conciencia.
- **Piezas dentales fracturadas o luxadas:** suponen riesgo de aspiración.
- **Hemorragia intraoral** puede dificultar la intubación, así como producir obstrucción de la vía aérea.
- **La inflamación de los tejidos blandos y edema. Quemaduras. Lesiones de tráquea o laringe.**
- **Lesiones asociadas tanto intracraneales como medulares.**

Si existe compromiso de la vía aérea, se debe establecer una vía respiratoria definitiva que permitirá la ventilación asistida con oxígeno a través de un tubo endotraqueal con balón. Existen tres tipos de vía respiratoria definitiva:

- Intubación oro-traqueal: es la técnica de elección.
- Intubación naso-traqueal.
- Vía respiratoria quirúrgica: se debe realizar ante la incapacidad para la realización de intubación oro o nasotraqueal y si existe compromiso ventilatorio.

INDICACIONES TRAQUEOSTOMÍA

- Edema o hematoma partes blandas.
- Fractura mandibular conminuta o bilateral. Fracturas tipo Le FORT II / III (desplazamiento posteroinferior del maxilar fracturado).
- Presencia de cuerpos extraños: dientes, vomito, sangre, fragmentos óseos.
- Traumatismo laringotraqueal.
- Incapacidad para mantener la vía aérea permeable por otros medios.

BIBLIOGRAFÍA.

- Martín Granizo R, López Davis A. Cirugía Oral y Maxilofacial. Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial. 3ª ed. Barcelona: Médica Panamericana; 2011.
- Ward Booth P, Eppley BL, Schmelzeisen R. Traumatismos Maxilofaciales y reconstrucción facial estética. 1ª ed. Madrid: Elsevier; 2005.